

כאבי בטן

מחלות בבטן יכולות להיגרם מכל אחת מהמערכות העיקריות שבבטן. כאבים באזור הבטן הם סימן לבעיה. כאשר המטופל מתלונן על כאבים באזור הבטן דבר ראשון יש לשלול טראומה. אם אובחנה פגיעה כזו מפנים מייד לבית החולים.

סוגי כאבי בטן

כאב פנימי (visceral) - כאב המורגש בקירות הבטן ונובע מעלייה במתח (לחץ) על קירות הבטן המתבטא בגירוי של מערכת העצבים האוטונומית. כאב פנימי מאופיין ככאב עוויתי ועמום שקשה למקם אותו. הוא בא והולך בגלים ומלווה בתחושת בחילה, הקאות והזעה וכן בדופק מהיר (סימנים סימפטיים).

כאב גופני (somatic) - זהו כאב באיבר מסוים או בחלק מסוים של הבטן והוא נובע מגירוי כימי או חיידי לקרום הצפק (הפריטונאום). שלא כמו בכאב הפנימי זהו כאב ממוקם, חד וחותר. הכאב קבוע ומוחמר בשיעול או במגע.

כאב מוקרן (referred) - העצבים הם אלה שמעבירים את תחושת הכאב, אך המסלול שלהם לא מתוחם לאזור אחד. אף שעצב מעצבב מקום אחד, הוא עובר בעוד אזורים הנמצאים בין אותו אזור מעוצבב ובין אזור הכניסה של העצב לעמוד השדרה. לדוגמה, עצבים C4 ו-C5 יוצאים מאזור חוליות הצוואר ומעצבבים את הסרעפת וברך עוברים באזור הכתף. לכן, כאשר עצבים אלה יעבירו תחושת כאב מהסרעפת, הכאב יתבטא לא רק בבטן העליונה (אזור הסרעפת) אלא גם בכתף. תופעה זו נקראת הקרנת כאב. כאבים מוקרנים שכיחים לדוגמה: כאבים באזור הצוואר והכתף (נובעים מגירוי הסרעפת), כאבים באזור הירך והמפשעה (נובעים מאבן בשופכן היוצא מהכליה), כאב בגב תחתון עם הקרנה לעכוז (נובעים ממפרצת באבי העורקים הבטני).

הגורמים לכאב בטן

אחרי שהמטפל מיקם את הכאב וסיווג אותו, יש להבין מה הגורם להופעת הכאב.

דימום - אם יש חשד לדימום שהוא לא דימום קטן, יש להתייחס למקרה כטראומה בטנית.

תעוקה בטנית - גורם נוסף הקשור למערכת הדם הוא תעוקה בטנית (abdominal angina) עקב תסחיף שנתקע באחד מעורקי המעינים (mesenteric ischemia). במקרה זה, כמו בתעוקת חזה, יופיעו פתאום כאבים עזים, בדרך כלל לאחר מאמץ בטני (ארוחה). בגלל עלייה בצריכת החמצן של המעי והיצרות העורק לא מתאפשרת אספקת דם מתאימה.

מפרצת (aneurism) - היא הרחבה לא תקינה של חלק מדופן העורק. גם כאן מדובר בכאב פתאומי ועז המקרין לגב התחתון. הכאב יהיה פועם (לפי פעימות זרימת הדם בעורק) ומכיוון שהמפרצת מפריעה לזרימת הדם הלאה, המטפל ירגיש ירידה בעוצמת הדופק בגפיים התחתונות, שיכול להיות גם מלווה בחיורון יחסי של פלג הגוף התחתון שאחרי המפרצת.

בקע - מעיים הנמצאים בלחץ גדול בתוך חלל הבטן יחפשו פתח לבקוע דרכו. הנקודות הרגישות לבקע הן: מעבר הוושט בסרעפת, אזור הטבור ואזור המפשעה. אם הבקע מלווה בדלקת הוא ילווה בכאב מתמיד עז באזור הבקע.

אבנים בדרכי השתן (אבנים בכליות) - יתבטאו בכאב עז המקרין למפשעה. זהו כאב שיכול להיות מלווה בבחילות והקאות, ויפיע עם עוד סימני התייבשות (שתן מועט); מכיוון שמקום הכאב הוא באזור הגב התחתון, בחשש לאבנים בכליות אין לשלול גם מפרצת.

היריון חוץ-רחמי - מקרה ראוי להתייחסות מיוחדת הוא היריון חוץ-רחמי. העובר משתרש שלא ברחם (בדרך הכלל בחצוצרה), גדל לממדים גדולים מדי למקום השרשתו וזה עלול לגרום לקריעת החצוצרה. בעקבות קריעה

זו יתחיל דימום פנימי אף שלכאורה אין שום מנגנון של טראומה, ויופיעו סימני הלם תת־נפחי. הכאבים בבטן התחתונה יהיו כאבים חדשים. כשהמטפל מגיע לאישה בגיל הפוריות שאינה יכולה לשלול בוודאות אפשרות להיריון, ויש לה הופעה פתאומית של כאב חד וחולשה כללית לא מוסברת, אין לשלול היריון חוץ־רחמי, ובמקרה זה מדובר בטראומה בטנית ויש להתייחס בהתאם ולפנותה בדחיפות.

הגישה למצב חירום בטני

לאחר שהמטפל שלל טראומה, יש לנתח את המקרה כדי להגיע לאבחנה משוערת למקור הכאב ובהתאם לכך לקבוע את אופן הטיפול. יש להשתמש בשיטת ה־OPQRST-A.

טבלה 14.1 סיווג של כאב בטני - OPQRST-A

O	Onset	התחלה	מתי הכאב התחיל? מה גרם לו להופיע? האם היה קשר לאכילה?
P	Position	תנוחה	האם הכאב משתנה לפי התנוחה? אילו גורמים מגבירים את הכאב?
Q	Quality	סיווג	סוג הכאב. תיאור הכאב: כאב קבוע? התקפי?
R	Radiation	הקרנה, מקום	מקום, איפה כואב והאם הכאב מקרין למקומות אחרים (או שהם מקרינים אליו)?
S	Severity	חומרה	דרגת חומרת הכאב (סובייקטיבית לפי המטופל, תוך שימוש בסרגל כאב)
T	Time	זמן	כמה זמן הכאב נמשך?
A	Associated signs	סימנים נלווים	מחפשים סימנים נלווים: בחילות והקאות, שינויים ביציאות, שינויים במחזור, כאבים בחזה (לזכור שכאב בבטן יכול להיות מוקרן ממקום אחר כמו הלב) וקשיי נשימה.

נוסף על התשאול הרפואי יש לעשות למטופל בדיקה גופנית. יש לשים לב לתנוחת המטופל ולצבע עורו (חיורון - אולי הוא בהלם). כמו כן יש לעקוב אחר הסימנים החיוניים ולבצע בדיקה פיזיקלית של הבטן עצמה ולבדוק אם יש גושים (אם אחד מהם פועם), אם יש שינוי צורה, אם הבטן רכה או קשה. בכל מקרה אין להאריך בבדיקה הפיזיקלית ויש להימנע מגרימת אינוחות למטופל.

הטיפול בכאב בטני

- 1) מוודאים נתיב אוויר פתוח
- 2) אם הסטורציה נמוכה - מספקים חמצן בריכוז מרבי
- 3) פותחים וריד ומספקים נוזלים לפי הצורך
- 4) מנטרים קצב הלב
- 5) מפנים תוך דיווח לפי הממצאים

טראומת בטן

בפגיעות בטן יש כמה בעיות מהותיות. קשה מאוד לאבחן את הפגיעה ואת רמת חומרתה. נוסף על כך, בדימום תוך־בטני אי אפשר לעצור את מקור הדימום בתנאי טרום־אשפוז אלא רק בחדר ניתוח. פגיעות בטן עלולות לגרום לעיתים קרובות לדימום תוך־בטני נרחב מכיוון שחלל הבטן הוא חלל גדול ובעל יכולת התרחבות רבה, דבר שגורם להמשך הדימום ולהלם תת־נפחי. פגיעות בטן עלולות להיות משולבות עם פגיעות חזה מסכנות חיים עקב הקרבה האנטומית בין החזה לבטן. לכן, פגיעות בטן נחשבות למקרי חירום הדורשים פינוי דחוף לחדר ניתוח.

סוגי פגיעות בטן

יש מנגנוני פגיעה שונים שיכולים להסב נזק בחלל הבטן: פגיעה חודרת, פגיעה קהה, פגיעת הדף. יש להביא בחשבון את העובדה שלחלל הבטן אין הגנה גרמית, ולכן היא חשופה מאוד לפגיעות, אפילו ממנגנונים קלים.

פגיעה חודרת

פגיעה כזו בדרך כלל נראית לעין, אך ייתכן שכיווץ אזור הפגיעה על ידי שרירי הבטן יסתיר את מקום החדירה. הפגיעה יכולה להיגרם מקליע של רובה או אקדח ובמקרים אלו הפגיעה יכולה לגרום לא רק לפגיעה במקום החדירה של הכדור, אלא בכל הרקמה שמסביב לאזור החדירה ולאורך מסלול הקליע בתוך פנים הבטן, בשל האנרגיה הרבה וגל ההדף שהכדור יוצר בחלל הבטן. גם דקירת סכין היא פגיעה חודרת. אומנם זוהי פגיעה נקודתית אך גם היא יכולה להסב נזק רב לאיברים פנימיים באזור הדקירה. הנזק תלוי בגודל הסכין באורכה ובתנועת הדקירה (הרחבה בפרק 2).

יש הבדלים בין שכיחות פגיעות בטן חודרות לפי מקום הפגיעה:

ירייה

מעידק - 50%

מעידגס - 40%

כבד - 30%

כלי דם גדולים - 25%

דקירה

כבד - 40%

מעידק - 30%

מעידגס - 25%

סרעפת - 20%



תמונה 14.1 פגיעה חודרת